DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: MARIA FLORALBA MEDINA **Identificación** CC 29871894
Edad: 80 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS S.A CONTRIBUTIVO-2025
Sala: QUIROFANO 5 **Fecha programación de cirugía:** 03/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**540013**	**DRENAJE DE COLECCION INTRAPERITONEAL VIA ABIERTA**	Y39	

Cirujano: BAYRON HUMBERTO RUANO BOLAÑOS **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: ABDOMEN

1	**545001**	**LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA ABIERTA**	Y40	

Cirujano: BAYRON HUMBERTO RUANO BOLAÑOS **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: ABDOMEN

1	**545001**	**NUEVO CIERRE DE DISRUPCION POSTOPERATORIA DE PARED ABDOMINAL (EVISCERACION) SOD**	Y40	

Cirujano: BAYRON HUMBERTO RUANO BOLAÑOS **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: ABDOMEN

1	**547702**	**RETIRO DE DISPOSITIVO PARA CIERRE TEMPORAL DE PARED ABDOMINA L VIA ABIERTA**	Y40	

Cirujano: BAYRON HUMBERTO RUANO BOLAÑOS **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: ABDOMEN

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES218 BAYRON HUMBERTO RUANO BOLAÑOS **Especialidad** CIRUGIA GENERAL

540013 **DRENAJE DE COLECCION INTRAPERITONEAL VIA ABIERTA**
545001 **LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA ABIERTA**
546100 **NUEVO CIERRE DE DISRUPCION POSTOPERATORIA DE PARED ABDOMINAL (EVISCERACION) SOD**
547702 **RETIRO DE DISPOSITIVO PARA CIERRE TEMPORAL DE PARED ABDOMINA L VIA ABIERTA**

Dx Preoperatorio: K550 TRASTORNO VASCULAR AGUDO DE LOS INTESTINOS

Dx Postoperatorio: K550 TRASTORNO VASCULAR AGUDO DE LOS INTESTINOS

Tipo de Herida: SUCIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 03/11/26 **Fecha Final** 03/11/26
Hora Inicio 07:40:00 **Hora Final** 08:55:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
FIRMA DE CONSENTIMIENTOS INFORMADOS, PARADA DE SEGURIDAD, LISTA DE CHEQUEO
ASEPSIA Y ANTISEPSIA CON CLORHEXIDINA.
- RETIRO DE SISTEMA DE CIERRE TEMPORAL: IOBAN, DOS ESPUMAS DE POLIURETANO, IOBAN. ACCESO A CAVIDAD PERITONEAL.
** HALLAZGOS.
- SE LIBERA MULTIPLES ADHERENCIAS INTERASALES DESCRITAS PARA REVISION DE LA TOTALIDAD DEL INTESTINO Y DETERMINAR LA NO VIABILIDAD.
- DRENAJE DE COLECCIONES EN LOS 4 CUADRANTES.
INFORMAN CONTEO COMPLETO DE COMPRESAS E INSTRUMENTAL.
SE PRACTICA NUEVO CIERRE DE PARED CON POLIPROPILENE 1, RAFIA CONTINUA EN PIEL.
SE TOMO REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS HALLAZGOS Y SE INFORMO A LA FAMILIA LA CONDICION DE LA PACIENTE Y PRONOSTICO (MORTALIDAD A CORTO PLAZO).
Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :
DOS INTERVENCIONES PREVIAS PARA CIERRE DE COLOSTOMIA Y POSTERIOR REINTERVENCION POR ISQUEMIA MESENTERICA,

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

REALIZARON HEMICOLECTOMIA IZQUIERDA, RESECCION SEGMENTARIA DE INTESTINO DELGADO + ANASTOMOSIS Y COLOSTOMIA DERIVATIVA. LLEVADA A LAVADO ENCONTRANDOSE:
1. ANASTOMOSIS DE INTESTINO DELGADO CON NECROSIS EN LOS BORDES Y FILTRACION DE LIQUIDO INTESTINAL.
2. MULTIPLES AREAS NECROTICAS EN TODO EL INTESTINO DELGADO DESDE LOS 20 CM DEL ANGULO DE TREIZT HASTA LA VALVULA ILEOCECAL CON FILTRACION DE LIQUIDO INTESTINAL, NECROSIS EN PARCHES EN COLON DERECHO, NECROSIS DE BORDES DE COLOSTOMIA EN FLANCO IZQUIERDO (LESIONES INCOMPATIBLES CON LA VIDA).
2. ADHERENCIAS INTERASALES FIRMES EN LOS 4 CUADRANTES.
3. COLECCIONES DE LIQUIDO INTESTINAL EN LOS 4 CUADRANTES (300 CC).
4. ABDOMEN ABIERTO CON SISTEMA VAC TIPO GENADYNE FUNCIONAL DRENANDO ESCASO LIQUIDO VERDOSO DE ASPECTO INTESTINAL.

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
AX619	HAROLD FERNANDO CHACON FLOR	ANESTESIOLOGO
MG30	LEONARDO INSIGNARES	AYUDANTE

Dr. Bayron Ruano Bolaños
Cirugía General

BAYRON HUMBERTO RUANO BOLAÑOS
Reg. 55399
CIRUGIA GENERAL

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***